

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE PLACER DE SNAITH-HAMILTON (SHAPS)

Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo • Evaluación de Tono Hedónico y Anhedonia Clínica

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Placer de Snaith-Hamilton (SHAPS).
Nombre Original (Inglés)	<i>Snaith-Hamilton Pleasure Scale (SHAPS)</i>
Autores Originales	R. Philip Snaith, M. Hamilton, S. Morley, A. Humayan, D. Hargreaves y P. Trigwell (1995).
Adaptaciones Españolas	Bobes et al. (2000, validación clínica española); Franken et al. (2007); Fuentes et al. (2018).
Eje Clínico y Clasificación	Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo. Evaluación de afecto positivo, anhedonia consumatoria y social.
Tipo de Instrumento	Autoinforme de 14 ítems con formato de 4 alternativas corregido dicotómicamente (0 ó 1).
Población y Rango	Adultos y adolescentes (≥ 16 años). Trastornos del estado de ánimo, esquizofrenia y adicciones.
Tiempo de Administración	3 a 5 minutos.
Régimen de Licencia	Dominio público para uso clínico y de investigación no comercial.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y NEUROBIOLOGÍA DE LA ANHEDONIA

La SHAPS fue diseñada específicamente para evaluar la **anhedonia** —la incapacidad o marcada disminución para experimentar placer en actividades que previamente resultaban gratificantes—, considerada un síntoma cardinal y criterio diagnóstico mayor tanto del Trastorno Depresivo Mayor (especialmente del subtipo melancólico) como de los síntomas negativos de la Esquizofrenia y trastornos adictivos.

Desde una perspectiva neurobiológica, la anhedonia refleja una alteración funcional en los circuitos mesocorticolímbicos de recompensa (corteza prefrontal ventromedial, estriado ventral y núcleo accumbens), mediada por hipodopaminergia y desregulación opioide. A diferencia de otras escalas de disfrute influenciadas por estatus socioeconómico o limitaciones físicas (como practicar deportes o viajar), la SHAPS evalúa actividades sensoriales y cotidianas universales (oler flores, ver reír a otros, saborear una bebida), garantizando una medida pura de la capacidad hedónica consumatoria.

3. DOMINIOS EVALUADOS EN LA SHAPS (SNAITH ET AL., 1995)

Dominio Hedónico	Ítems	Rango Dir.	Contenido y Significación Fenomenológica
1. Intereses / Pasatiempos	1, 3, 9	0 a 3	Capacidad de disfrutar programas favoritos, aficiones personales y lectura interesante.
2. Interacción Social	2, 7, 13, 14	0 a 4	Placer derivado del contacto íntimo familiar, ver sonreír a otros, ayudar a prójimos y recibir halagos.
3. Experiencias Sensoriales	4, 5, 6, 10	0 a 4	Placer consumatorio básico: comida preferida, baño/ducha agradable, aromas placenteros y bebidas.
4. Disfrute General / Vital	8, 11, 12	0 a 3	Cuidado del aseo personal, disfrute de pequeños detalles del día a día y contemplación de paisajes.
PUNTUACIÓN TOTAL SHAPS	1 al 14	0 a 14	Índice acumulativo estándar de anhedonia clínica (método de corrección dicotómica).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA

Consistencia Interna	Excelente homogeneidad: alfa de Cronbach de 0.88 a 0.92 en muestras clínicas españolas (Bobes et al., 2000; Fuentes et al., 2018).
Estabilidad Temporal	Elevada confiabilidad test-retest $r = 0.82$ en pacientes estables en un intervalo de dos semanas.
Sensibilidad y Especificidad	Para el punto de corte clínico estándar $ge3$: sensibilidad del 89% y especificidad del 91% en la detección de depresión mayor con síntomas melancólicos.
Validez Concurrente	Correlación negativa significativa con escalas de afecto positivo (PANAS-PA $r = -0.68$) y correlación positiva robusta con ítems de anhedonia de la MADRS ($r = 0.74$) y HAM-D ($r = 0.70$).
Sensibilidad al Cambio	Demuestra una reducción estadísticamente significativa en respuesta a antidepresivos dopaminérgicos y noradrenérgicos, así como a intervenciones de activación conductual.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN ESTÁNDAR (SNAITH ET AL., 1995)

La escala evalúa la capacidad de disfrute en los **últimos días**. Las respuestas se registran en 4 categorías:

- **Totalmente de acuerdo (TA)** y **De acuerdo (A)**: Indican capacidad conservada de experimentar placer -> **Se asignan 0 puntos**.
- **En desacuerdo (D)** y **Totalmente en desacuerdo (TD)**: Indican pérdida o deterioro del placer hedónico -> **Se asigna 1 punto**.
- **Puntuación Total SHAPS**: Suma de las respuestas codificadas como 1 punto. Rango: **0 a 14 puntos**.

TA = 0 | A = 0 | D = 1 | TD = 1 (Mayor puntuación = Mayor anhedonia)

6. BAREMOS Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Nivel	Puntuación	Estado Hedónico	Conducta Asistencial Recomendada
Normal	0 a 2	Capacidad hedónica conservada	Respuestas placenteras preservadas en la vida cotidiana. Mantener actividades gratificantes y autocuidado.
Anhedonia	3 a 14	Corte Clínico Positivo (Anhedonia)	Pérdida clínicamente significativa de la reactividad hedónica. Fuerte indicador de episodio depresivo melancólico o sintomatología negativa.

GRADIENTE DE SEVERIDAD EN ANHEDONIA: Dentro del rango clínico ($ge3$), puntuaciones de 3 a 5 reflejan anhedonia moderada (frecuente en episodios depresivos leves a moderados), mientras que puntuaciones $ge6$ indican una anestesia afectiva grave o anhedonia completa consumatoria y social.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E IMPLICACIÓN TERAPÉUTICA

IMPLICACIONES EN PSICOTERAPIA Y PSICOFARMACOLOGÍA:

- **Resistencia a ISRS:** La persistencia de anhedonia severa (SHAPS *ge6*) tras remisión de tristeza con ISRS sugiere “embotamiento emocional inducido por antidepresivos”. Se recomienda valorar agentes dopaminérgicos/noradrenérgicos (bupropión, vortioxetina) o agonistas melatoninérgicos (agomelatina).
- **Activación Conductual (AC):** El análisis por ítems permite identificar qué canales de refuerzo siguen mínimamente permeables (comida, naturaleza) para iniciar la programación gradual de actividades placenteras antes de escalar a refuerzos sociales complejos.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: MONITORIZACIÓN EN DEPRESIÓN RESISTENTE

Paciente: Mujer de 52 años, profesora de instituto, en tratamiento con escitalopram 20 mg/día por Episodio Depresivo Mayor. Aunque ya no presenta crisis de llanto ni ideación catastrófica, persiste quejándose de “sentirse como un robot vacío, incapaz de disfrutar de nada”.

Puntuación SHAPS Total: 9/14 (Anhedonia Severa).

• **Desglose por dominios:** Interacción social = 4/4 (no disfruta con familia ni recibiendo elogios); Pasatiempos = 3/3 (ha abandonado la lectura y pintura); Experiencias sensoriales = 2/4 (la comida le sabe a cartón, solo mantiene agrado en la ducha tibia).

Conducta Asistencial: Se diagnostica remisión incompleta con anhedonia residual y embotamiento afectivo. Se ajusta la pauta farmacológica añadiendo bupropión 150 mg/día y se implementa psicoterapia basada en Activación Conductual y **Savoring** (atención plena a sensaciones sensoriales agradables). A las 6 semanas, la puntuación en la SHAPS se reduce a 2/14 (tono hedónico normalizado), reactivando la interacción familiar y el disfrute en aficiones.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y EXPLORACIÓN COMPLEMENTARIA

ALERTA: RIESGO DE SUICIDIO

La anhedonia severa es un factor predictor independiente de conducta suicida, incluso en ausencia de tristeza manifiesta. Puntuaciones SHAPS ≥ 6 requieren exploración inmediata de ideación autolítica activa.

VALORACIÓN MOTIVACIONAL

La SHAPS mide anhedonia consumatoria (disfrute en el momento). Ante quejas de “falta de ganas”, debe complementarse con escalas de motivación y anhedonia anticipatoria (como TEPS o DARS).

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Snaith, R. P., Hamilton, M., Morley, S., Humayan, A., Hargreaves, D., & Trigwell, P. (1995). A scale for the assessment of hedonic tone the Snaith-Hamilton Pleasure Scale. *The British Journal of Psychiatry*, 167(1), 99–103.
2. Bobes, J., González, M. P., Bascarán, M. T., Corominas, A., Sáiz, P. A., & Bousoño, M. (2000). Validación de la versión española de la Escala de Placer de Snaith-Hamilton (SHAPS). En *Banco de Instrumentos Básicos para la Práctica de la Psiquiatría Clínica*. Ars Medica.
3. Franken, I. H., Rassin, E., & Muris, P. (2007). The assessment of anhedonia in clinical and non-clinical populations: Further validation of the Snaith-Hamilton Pleasure Scale (SHAPS). *Journal of Affective Disorders*, 99(1-3), 83–89.
4. Treadway, M. T., & Zald, D. H. (2011). Reconsidering anhedonia in depression: lessons from translational neuroscience. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 35(3), 537–555.